心包炎 与一般心包炎鉴别:贫血

心肌病变←慢性肾衰主要死因:心衰

RAAS

水钠潴留→高血压

（1）心肌损害

①原发：缺血（如冠心病最主要）、炎症和免疫（如心肌炎、扩心病）、遗传（如肥心病、扩心病）等

②继发：代谢（如糖尿病、甲亢、甲减）、心脏毒性药物等 蒽环类药物(柔红霉素)

对全身都有毒性,只是对心脏毒性最明显

三、病因和诱因

回心血量↑→容量负荷↑→心排出量↑

（一）病因 长期:心排出量有所下降,但仍高于正常

不能满足机体需求(心衰)



（2）负荷 《生理》:后负荷=大动脉血压 e.g高血压、肺动脉高压

《内科》:后/压力负荷:心脏收缩遇到的负荷 e.g高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭

①**后负荷/压力负荷**过重：如高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭 P2↓ A2↓

②**前负荷/容量负荷**过重：如心瓣膜关闭不全、动脉导管未闭、间隔缺损、伴回心血量增多的疾病（高排量心衰）

动脚评价人

③前负荷不足：如二狭 不会涉及到左室收缩功能明显下降,是因为左房压力增高导致肺淤血、肺水肿

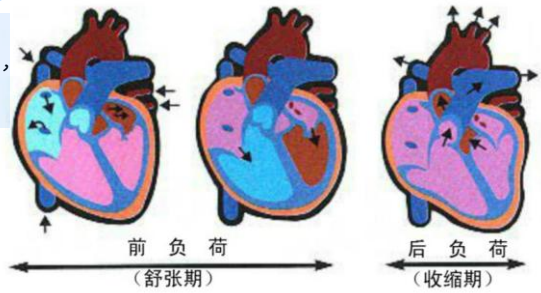
最容易左心衰、最容易房颤、最容易脑栓塞

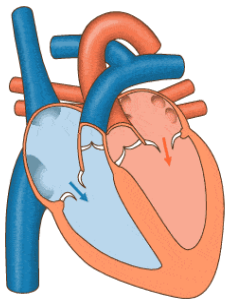
甲亢是高排量心衰还是低排量心衰要分情况

①对青年人,心脏承受能力强,一般没有心脏基础疾病,往往是高排量心衰

②对老年人,恶化原有的心脏病,往往是低排量心衰

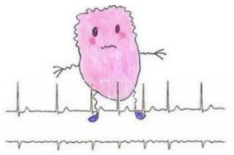






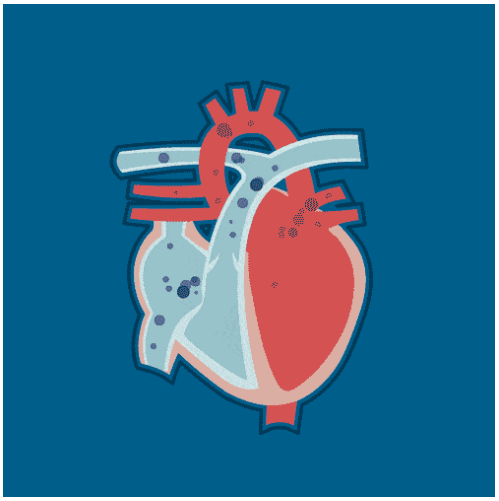
（二）诱因 诱因-放在正常人身上不会发病

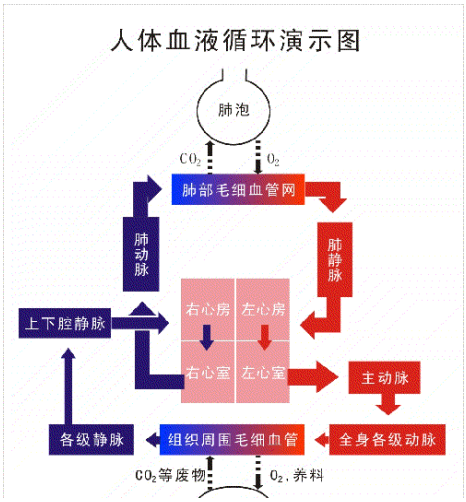
病因-放在正常人身上也会发病



感染	呼吸道感染最常见
心律失常	房颤等 心率越快,回血越少
血容量增加	静脉输液过多过快等 补碱补5%NaHCO3(高渗→血容量↑)
过度劳累、情绪激动	妊娠后期、ttsx 分娩等
治疗不当	不恰当停用原有治疗心衰的药
原有心脏病变加重	急性心梗若出现心衰→冠心病发生心梗为心衰的病因 急性心梗若此时没有心衰、以后由于其它原因所致心衰→冠心病发生心梗为心衰的诱因

四、临床表现——淤血





左心衰-肺循环淤血、水肿

右心衰-体循环淤血、水肿